Waluu — Documentation des scénarios

Oct 16, 2026 · @Someone

Objet et préparation

Ce document décrit les scénarios de bout en bout de Waluu, le portail de transfert de patients entre les hôpitaux de Dakar. Chaque scénario sert à la fois de **script de démonstration** et de **cas de recette** : acteurs, prérequis, déroulé, résultat attendu et dernier résultat de test. Les règles citées (RG-xx) renvoient à la documentation fonctionnelle.

Instance : PDI `dev408543.service-now.com`, portail https://dev408543.service-now.com/transferts (nom affiché « Waluu »).

Utilisateurs de démonstration (sans mot de passe, à jouer avec *Impersonate* depuis l'interface classique) :

Acteur	Utilisateurs
Régulateur	`reg.demo`
Coordinateurs	`coord.fann`, `coord.principal`, `coord.albertroyer`, `coord.dalaljamm`, `coord.idrissapouye`, `coord.madeleine`, `coord.abassndao`
Agents d'établissement	`agent.dalaljamm`, `inf.fann.cardio`, `agent.albertroyer`, `agent.principal`, `agent.idrissapouye`, `agent.madeleine`, `agent.abassndao`
Ambulanciers	`amb.plateau1`, `amb.plateau2`, `amb.fann1`, `amb.fann2`, `amb.banlieue1`, `amb.banlieue2`
Dispatchers	`disp.plateau`, `disp.fann`, `disp.banlieue`

Données de référence : 7 hôpitaux de Dakar (positions GPS réelles, capacités fictives), 3 zones (Plateau-Médina, Fann-Grand Yoff, Pikine-Guédiawaye), 44 équipements médicaux, 12 véhicules sanitaires, règles d'équipement (2 respirateurs, 2 couveuses, 2 moniteurs libres minimum).

Délais (SLA) : réponse 5 min (vitale) et 15 min (urgente) ; prise en charge 10 min (vitale) et 15 min (urgente) ; programmée : réponse sous 24 h, pas de délai de prise en charge.

Conseils pour jouer un scénario : ouvrir deux navigateurs (ou une fenêtre privée) pour voir en temps réel l'effet d'une action d'un acteur chez un autre ; garder la page Carte ouverte chez le régulateur ; les minuteurs tournent à la seconde, une demande vitale expire en 5 min sans acceptation.

Scénarios nominaux

Deux transferts complets, de la saisie à l'arrivée du patient, tiennent leurs délais.

S1 — Transfert vital de bout en bout (Abass Ndao → CHNU de Fann)

- **Acteurs** : `agent.abassndao` (demandeur), `coord.fann` (coordinateur), `reg.demo` (régulateur), ambulancier de la zone Plateau-Médina.
- **Prérequis** : Fann a au moins 1 lit libre en réanimation et 2 respirateurs et 2 moniteurs libres.

1. L'agent clique « Nouvelle demande » : origine, service et téléphone sont pré-remplis. Il choisit Réanimation, urgence Vitale, et envoie.
2. La demande est publiée aux établissements éligibles ; le bandeau affiche « Réponse attendue » avec un compte à rebours de 5:00.
3. Le coordinateur de Fann voit la carte « À traiter » avec la distance (1,4 km) et accepte en choisissant le service.
4. Le régulateur voit « Réponse en m:ss ✓ » et le chrono de décision ; Fann porte « tient les 10 min ». Il clique « Retenir cette destination ».
5. À la retenue : lit réservé, respirateur et moniteur réservés, ambulance réservée, itinéraire routier calculé, tâche « Transport du patient » créée et assignée, minuteur « Arrivée exigée » de 10:00.
6. L'ambulancier, dans « Mes missions » : Accepter, Je pars, Arrivé à Abass Ndao, Patient pris en charge, puis Terminer avec une note.

Résultat attendu : demande « Arrivé - clôturée », bilan « Réponse ✓ · Prise en charge ✓ », ordre FSM clôturé, véhicule et équipements libérés, les deux SLA terminés sans dépassement. Le coordinateur de Fann a vu le patient dans « Arrivées attendues » tout au long du trajet.

Dernier test (16/10/2026, TRF0001043) : réponse 1:13 / 5:00, approche 2 + route 5 + remise 2 min, prise en charge 3:20 / 10:00 ✓.

S2 — Transfert urgent (Abass Ndao → Hôpital Principal)

- **Acteurs** : demandeur, `coord.principal`, `reg.demo`, ambulancier.

- **Différences avec S1** : délais de 15 min pour la réponse et pour la prise en charge ; cardiologie avec moniteur.

1. Publier une demande Urgente en cardiologie.
2. Faire accepter par Principal, puis retenir.
3. Vérifier la fenêtre FSM de 15 min et la carte « Trajet du patient ».

Résultat attendu : compte à rebours de 15:00 à chaque étape, tâche planifiée dans la fenêtre, ambulance qui avance sur la carte après « Patient pris en charge ».

Dernier test (15/10/2026, TRF0001038) : délais 15 / 15 min, transport planifié dans la fenêtre (modèle à 3 tâches de l'époque).

Scénarios de sélection des établissements

Seuls les établissements capables d'accueillir le patient reçoivent la demande (RG-01) ; la distance aide à choisir sans exclure (RG-25).

S3 — Exclusion par la règle de quantité d'équipement

- **Prérequis** : Dalal Jamm a un lit libre en réanimation mais un seul respirateur ; règle « Respirateur de réanimation : 2 unités libres ».

1. Publier une demande de réanimation avec respirateur et moniteur depuis Abass Ndao.
2. Consulter la liste des établissements sollicités.

Résultat attendu : Fann et Idrissa Pouye sont sollicités, Dalal Jamm ne l'est pas ; Principal et Albert Royer sont exclus faute de lit.

Dernier test (15/10/2026, TRF0001025) : conforme.

S4 — Équipements réservés, puis rendus

1. Retenir Fann pour la demande de S3.
2. Ouvrir *Transport (FSM) > Réservations en cours*.
3. Annuler la demande.

Résultat attendu : `FANN-RESP-1`, `FANN-MONI-1` et l'ambulance de la zone d'origine sont réservés à la retenue, puis « Libérée » avec le motif « Demande annulée » ; une unité réservée n'est pas comptée libre pour une autre demande.

Dernier test (15/10/2026, TRF0001025) : 3 réservations créées puis libérées.

S5 — Choisir l'établissement le plus proche

1. Publier une demande de médecine depuis Dalal Jamm et faire accepter deux établissements.
2. Ouvrir la demande en tant que régulateur.

Résultat attendu : réponses triées de la plus proche à la plus éloignée, chacune avec « X km · ≈ Y min de route » et « tient les N min » ou « délai intenable » ; badge « Le plus proche » sur l'établissement accepté le plus proche ; la carte « À traiter » du coordinateur affiche la distance.

Dernier test (15/10/2026, TRF0001034) : 4 réponses de 8 km à 13,7 km, badge sur Abass Ndao.

S6 — Carte des hôpitaux en temps réel

1. Ouvrir la page *Carte* (régulateur), choisir la spécialité Réanimation.
2. Dans un autre navigateur, un coordinateur passe un service à 0 lit libre.

Résultat attendu : les 7 hôpitaux à leur position, colorés selon les lits libres ; la marque de l'hôpital concerné passe au rouge sans recharger ; ambulances par zone et transferts en cours tracés.

Dernier test (15/10/2026) : données conformes côté serveur ; rendu à vérifier dans un navigateur.

Scénarios de délais

Les délais sont suivis par des SLA standard ; un dépassement est signalé, il ne bloque pas la prise en charge.

S7 — Délai de prise en charge intenable

1. Publier une demande vitale depuis Dalal Jamm (Guédiawaye) ; faire accepter Fann (≈ 40 min de route).
2. Avant de retenir, regarder la réponse de Fann.
3. Retenir Fann.

Résultat attendu : la réponse affiche « délai de 10 min intenable » ; à la retenue, la tâche suit la durée réelle et la demande reçoit la note « Délai de prise en charge intenable : arrivée planifiée à HH:MM pour une échéance à HH:MM » ; le SLA de prise en charge garde son échéance de 10 min et passe en dépassement.

Dernier test (15/10/2026, TRF0001039) : estimation 43 / 10 min signalée, alerte posée.

S8 — Expiration d'une demande vitale sans réponse

1. Publier une demande vitale et ne répondre nulle part.
2. Observer le compte à rebours, rouge sous 1 min.

Résultat attendu : moins d'une minute après l'échéance (contrôle chaque minute), la demande passe « Expirée », les réponses en attente « Expirée », le SLA de réponse est en dépassement, le demandeur reçoit la notification et le bandeau affiche « Expirée sans acceptation ».

Dernier test (15/10/2026, TRF0001036) : expirée 25 s après l'échéance, SLA en dépassement.

S9 — Relance par un établissement, puis republication

- **Acteurs** : un coordinateur dont la réponse a expiré, le demandeur.

1. Sur la demande expirée de S8, le coordinateur voit « Vous avez manqué cette demande ? », choisit un service disponible et envoie la relance.
2. Le demandeur reçoit la notification et voit la relance sur sa demande.
3. Il clique « Republier la demande ».

Résultat attendu : une nouvelle demande est publiée avec les mêmes informations et une nouvelle date limite, reliée à l'ancienne (« Republication de … » / « Republiée en … ») ; la relance passe « Traitée » ; on ne peut plus republier l'ancienne.

Dernier test : validé lors de la livraison de la republication (14/10/2026) ; à rejouer avec les délais de 5 et 15 min.

Scénarios terrain (ambulancier)

L'ambulancier mène sa mission depuis la page « Mes missions », en attendant l'application mobile Field Service ; chaque bouton applique une transition Field Service standard (RG-29).

S10 — Mission complète depuis « Mes missions »

- **Acteur** : l'ambulancier assigné (par exemple `amb.plateau1`), sur téléphone.
- **Prérequis** : une destination vient d'être retenue (S1).

1. Ouvrir le portail : l'ambulancier arrive directement sur « Mes missions » ; la mission est en tête, « À accepter ».
2. Ouvrir la mission : carte du trajet, bouton Itinéraire, patient, véhicule, minuteur d'arrivée exigée.

3. Appuyer dans l'ordre : Accepter la mission, Je pars, Arrivé à l'origine, Patient pris en charge, Terminer.
4. Essayer « Terminer » sans note, puis avec une note.

Résultat attendu : chaque étape est horodatée (en route, sur place, pris en charge, remis) et visible en direct chez le régulateur et le coordinateur de destination ; sans note, « Ajoutez une note de remise » ; avec note, la mission est terminée, l'ordre clôturé et la demande « Arrivé ».

Dernier test (16/10/2026, TRF0001043, en tant qu' `amb.plateau1`) : conforme ; une action hors séquence est refusée.

S11 — Refus de mission

1. Sur une mission « À accepter », appuyer « Refuser » et saisir un motif.

Résultat attendu : la tâche repart au dispatch (Pending Dispatch) avec le motif en note ; elle disparaît des missions de l'ambulancier ; le dispatcher de la zone la voit dans *My Dispatch Queue* et la réaffecte.

Dernier test : à jouer.

S12 — Clôture incomplète

1. Pendant le transport, appuyer « Clôturer incomplète… » et saisir un motif (par exemple patient décédé ou refus de transport).

Résultat attendu : la tâche passe « Closed Incomplete » avec le motif ; l'ordre de transport signale une alerte sur la demande ; le régulateur décide de la suite (annulation ou nouvelle demande).

Dernier test : à jouer.

S13 — Réaffectation par le dispatch

1. Le dispatcher réaffecte la tâche à un autre ambulancier depuis Field Service.

Résultat attendu : la mission disparaît chez le premier ambulancier (ou affiche « Mission réaffectée par le dispatch ») et apparaît chez le nouveau, « À accepter ».

Dernier test : à jouer.

Scénarios d'exception

Les erreurs de saisie sont bloquées avec un message clair, et les imprévus libèrent les ressources réservées.

S14 — Refus d'un établissement et réponse définitive

1. Le coordinateur clique « Refuser » sans motif, puis avec le motif « Personnel insuffisant ».
2. Il tente de modifier sa réponse.

Résultat attendu : sans motif, refus bloqué (RG-06) ; avec motif, réponse « Refusée », horodatée et notifiée au demandeur ; le panneau de réponse disparaît : « Réponse envoyée : elle ne peut plus être modifiée » (RG-07). Accepter un service sans lit libre est aussi bloqué (RG-05).

Dernier test : validé lors de la livraison des réponses définitives (14/10/2026).

S15 — Annulation après la retenue

1. Retenir une destination, puis cliquer « Annuler la demande ».

Résultat attendu : demande « Annulée », réponses ouvertes « Non retenue », équipements et véhicule libérés (motif « Demande annulée »), SLA annulés. Limite connue : le lit réservé n'est pas rendu automatiquement, le coordinateur l'ajuste avec + (RG-14).

Dernier test (15/10/2026, TRF0001025) : réservations libérées.

S16 — Itinéraire routier indisponible

1. Rendre le service d'itinéraires injoignable (propriété `x_2218203_ptrans.itineraire.osrm_url` vers une adresse invalide), puis retenir une destination.
2. Remettre l'adresse d'origine après le test.

Résultat attendu : la retenue n'est pas bloquée ; note « Itinéraire routier indisponible : durée estimée à vol d'oiseau » ; la carte « Trajet du patient » trace une ligne directe.

Dernier test : à jouer.

S17 — Capacité à zéro

1. Le coordinateur de Principal passe sa réanimation à 0 lit libre avec −, puis on publie une demande de réanimation.

Résultat attendu : les lits libres ne descendent pas sous 0 (RG-15) ; Principal n'est pas sollicité ; sur la page Carte, sa marque est rouge en réanimation.

Dernier test (15/10/2026, TRF0001025) : Principal exclu à 0 lit.

Récapitulatif

9 scénarios sur 17 sont conformes au dernier test ; 4 restent à jouer, 3 sont à rejouer depuis l'évolution des délais et de la tâche unique, et 1 attend la vérification de son rendu. Les rendus visuels du portail (minuteurs, cartes) sont à vérifier dans un navigateur.

N°	Scénario	Acteur principal	Dernier test	Statut
S1	Transfert vital de bout en bout	Tous	16/10/2026, TRF0001043	Conforme
S2	Transfert urgent	Régulateur	15/10/2026, TRF0001038	À rejouer
S3	Exclusion par la règle de quantité	Régulateur	15/10/2026, TRF0001025	Conforme
S4	Équipements réservés puis rendus	Régulateur	15/10/2026, TRF0001025	Conforme
S5	Établissement le plus proche	Régulateur	15/10/2026, TRF0001034	Conforme
S6	Carte des hôpitaux en temps réel	Régulateur	15/10/2026	Rendu à vérifier
S7	Délai de prise en charge intenable	Régulateur	15/10/2026, TRF0001039	Conforme
S8	Expiration vitale sans réponse	Demandeur	15/10/2026, TRF0001036	Conforme
S9	Relance puis republication	Coordinateur, demandeur	14/10/2026	À rejouer
S10	Mission complète depuis « Mes missions »	Ambulancier	16/10/2026, TRF0001043	Conforme
S11	Refus de mission	Ambulancier	—	À jouer
S12	Clôture incomplète	Ambulancier	—	À jouer
S13	Réaffectation par le dispatch	Dispatcher	—	À jouer
S14	Refus d'un établissement, réponse définitive	Coordinateur	14/10/2026	À rejouer

N°	Scénario	Acteur principal	Dernier test	Statut
S15	Annulation après la retenue	Régulateur	15/10/2026, TRF0001025	Conforme
S16	Itinéraire routier indisponible	Régulateur	—	À jouer
S17	Capacité à zéro	Coordinateur	15/10/2026, TRF0001025	Conforme